UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Allergologie
Consultation post-choc anaphylactique
sans patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : Nadia **Date de rédaction : 08/12/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 299 – Consultation post évènement allergique

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Education/prévention

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Annonce

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Expliquer au patient les principes thérapeutiques
2- Expliquer au patient la nécessité de l'éviction de l'allergène identifié ou suspecté

3- Expliquer au patient les explorations allergologique adaptée

Patient simulé nécessaire à la station : OUI, un homme jeune

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table, 2 chaises, une ordonnance (ci-dessous)

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synospis : (décrivez en quelques lignes ici le résumé du rôle et précisez s'il y a un contact physique ou non)

Il y a 5 jours, vous avez mangé un pad thaï pour le déjeuner dans un restaurant thaïlandais. Après 15mn, des plaques rouges sont apparus sur tout le corps, votre gorge grattait, vos lèvres et paupières gonflaient. Vous n'arriviez plus à respirer. Votre ami sur place a appelé les pompiers. Ces derniers vous ont transporté aux urgences de Pasteur. Très vite, vous avez vu un médecin et une infirmière vous a fait une "piqure" dans la cuisse. Vous êtes restez sous surveillance plusieurs heures avant de rentrer chez vous. Avant votre sortie, l'urgentiste vous donne un compte rendu et une ordonnance pour la trousse de secours. Il vous programme également une consultation avec un allergologue.

L'interne (allergogue) vous interrogera et vous donnera une prise en charge. Aucun examen physique ne sera pratiqué.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom: HANKS; Prénom : Tom Age : 24 ans Etudiant en journalisme
Antécédents	Eczéma Aucune allergie connue avant cet épisode
Médicaments actuels/ Toxiques	*Dermocorticoïde en crème*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : assis Douleur : aucune Angoisse : Moyenne, vous avez cru que vous alliez mourir Colère : aucune Autre : Se pose beaucoup de question pour la suite. Vous n'avez pas compris
Déroulement du scénario	Vous êtes assis Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : ***"Il y a 5 jours j'ai mangé un pad thaï. Et quelques minutes après j'avais des plaques, mon visage a gonflait et je n'arrivais plus à respirer."*** Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement.

	(Préciser si le patient doit poser une question 1 min avant la fin)
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	Comment suis-je sensé utiliser chaque médicament ?

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Avez-vous été reçus aux urgences ?	Oui, les pompiers m'ont transporté jusqu'aux urgences.
Qu'est ce que le médecin des urgences vous a dit ?	Il m'a dit que j'ai fait une réaction allergique à un des ingrédients que j'ai mangé.
Quel(s) soin(s) avez-vous eu aux urgences ?	Je ne sais pas vraiment. Je me souviens seulement qu'une infirmière m'a fait une piqure dans la cuisse. Puis une deuxième peu de temps après.
Le médecin vous a-t-il donné des directives à suivre ?	Oui, il m'a donné une ordonnance avec des traitements mais je n'ai pas vraiment compris comment les utiliser.
Avez-vous déjà consommé ce repas auparavant ?	Oui, je suis un habitué de ce restaurant
Avez-vous mangé ou bu autre chose avant le repas ?	Non, je n'ai rien mangé de la matinée. La seule chose que j'ai mangé c'est le pad thaï.
Avez-vous déjà eu des allergies ?	Non jamais.
Un membre de votre famille a-t-il des allergies ?	Non personne à ma connaissance.
Avez-vous des maladies particulières ?	J'ai de l'eczéma.
Avez-vous des traitements ?	Des corticoïdes en crème pour l'eczéma.
Fumez-vous du tabac ou autres drogues ? Buvez-vous de l'alcool	Je ne fume pas. Je ne bois pas.

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en HDJ de pneumologie au CHU de Pasteur.

Vous recevez en consultation Mr Y, 35 ans. Il y a 48 heures, ce dernier a présenté une réaction allergique après avoir mangé dans un restaurant thaïlandais avec un ami.

Sur le TU des urgences, vous lisez le compte-rendu suivant :
« Il y a 5 jours, le patient a mangé un pad thaï pour le déjeuner dans un restaurant thaïlandais. Après 15mn, des plaques rouges sont apparus sur tout le corps, sa gorge grattait, ses lèvres et paupières gonflaient. Il n'arrivait plus à respirer. Les secours, appelés rapidement, vous ont transporté aux urgences de Pasteur.

Injection d'adrénaline dans la cuisse par l'urgentiste. Dosage tryptase : élevée. Surveillance du patient plusieurs heures avant RAD. Trousse de secours (ordonnance) fournie au patient. Programmation d'une consultation allergologique. »

Vous avez 8 minutes pour :

1. **Expliquer** au patient ce qui lui est arrivé, en reprenant l'anamnèse fournie

2. Donner les **futures explorations** à réaliser

3. Expliquer au patient la **prise en charge thérapeutique** à réaliser dès maintenant

Pas d'examen physique.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

Aptitudes cliniques	**Cocher si fait**
Tache 1	
Dire au patient qu'il a fait un choc anaphylactique	
Dire au patient qu'il a présenté un œdème de Quincke/ angioœdème	
Explique que le choc anaphylactique est une réaction : - immunologique majeure - brutale et grave - qui menace le pronostic vital *OK si 1/3*	
Explique que la piqure était une <u>thérapeutique</u> qui a permis de <u>diminuer les gonflements</u> *OK si 1/2*	
Explique que dans son cas, il est fort probable que cela vienne de ce qu'il a mangé	
Tache 2	
Propose les tests cutané / Prick-test de tous les ingrédients présents dans le plat à faire dans 1 mois minimum	
Enonce la nécessité de faire les tests à distance du choc (1 mois)	
Propose dosage tryptase basale	
Propose dosage IgE spécifique	
Tache 3	
Expliquer éviction du ou des ingrédients suspects jusqu'aux tests.	
Expliquer utilisation auto-infection intra-musculaire avec stylo adrénaline i difficulté respiratoire ou malaise	
Injecter dans la cuisse en latéro-externe ou deltoïde	
Dire qu'il faut toujours avoir sur soi un stylo d'adrénaline	
Expliquer utilisation anti histaminique PO et corticoïde PO : Symptôme cutanéo-muqueux uniquement (prurit, urticaire)	
Dire d'appeler le 15 au moindre problème	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à fournir les renseignements au patient	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge aigue et chronique	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

Aptitudes cliniques	**Cocher si fait**
Tache 1	
Dire au patient qu'il a fait un choc anaphylactique	5
Dire au patient qu'il a présenté un œdème de Quincke/ angioœdème	5
Explique que le choc anaphylactique est une réaction : - immunologique majeure - brutale et grave - qui menace le pronostic vital *OK si 1/3*	3
Explique que la piqure était une <u>thérapeutique</u> qui a permis de <u>diminuer les gonflements</u> *OK si 1/2*	5
Explique que dans son cas, il est fort probable que cela vienne de ce qu'il a mangé	5
Tache 2	
Propose les tests cutané / Prick-test de tous les ingrédients présents dans le plat à faire dans 1 mois minimum	5
Enonce la nécessité de faire les tests à distance du choc (1 mois)	5
Propose dosage tryptase basale	3
Propose dosage IgE spécifique	5
Tache 3	
Expliquer éviction du ou des ingrédients suspects jusqu'aux tests.	5
Expliquer utilisation auto-infection intra-musculaire avec stylo adrénaline i difficulté respiratoire ou malaise	5
Injecter dans la cuisse en latéro-externe ou deltoïde	3
Dire qu'il faut toujours avoir sur soi un stylo d'adrénaline	5
Expliquer utilisation anti histaminique PO et corticoïde PO : Symptôme cutanéo-muqueux uniquement (prurit, urticaire)	3
Dire d'appeler le 15 au moindre problème	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à fournir les renseignements au patient	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge aigue et chronique	

Consultation post événement allergique SDD-299

Situation de départ		
Intitulé	Consultation post événement allergique	
Famille	Prise en charge aigüe et chronique	
Items de connaissance en rapport	Toxidermies Réaction inflammatoire : aspects biologiques et cliniques. Conduite à tenir Hypersensibilités et allergies chez l'enfant et l'adulte : aspects physiopathologiques, épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement Hypersensibilités et allergies cutanéomuqueuses chez l'enfant et l'adulte. Urticaire, dermatites atopique et de contact Hypersensibilité et allergies respiratoires chez l'enfant et chez l'adulte. Asthme, rhinite	Éducation thérapeutique, observance et automédication Identification et gestion des risques liés aux médicaments et aux biomatériaux, risque iatrogène, erreur médicamenteuse (voir items 4 et 5) Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus courantes chez l'adulte et chez l'enfant, hors anti-infectieux (voir item 177). Connaître le bon usage des principales classes thérapeutiques Œdème de Quincke et anaphylaxie Impact de l'environnement sur la santé.
Items de connaissance reliés, non traités ici	Responsabilités médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire. La gestion des erreurs et des plaintes ; l'aléa thérapeutique Dermatose bulleuse touchant la peau et/ou les muqueuses externes Soins et accompagnement dans la maladie chronique et le handicap	Agranulocytose médicamenteuse : conduite à tenir Prurit Éosinophilie
Items de connaissance reliés en general		

Attendu d'apprentissage dans la famille "Prise en charge aigüe et chronique"	Domaines	Compétence générique
Expliquer au patient les objectifs, les bénéfices et les effets indésirables attendus de la prise en charge - familles		
Transmettre les informations pertinentes aux différents acteurs de santé familles	Communication interprofessionelle	Coopérateur
Expliquer au patient les principes thérapeutiques - familles	Education/prévention	Communicateur
Evaluer l'observance thérapeutique - familles	Entretien/interrogatoire	Clinicien
Planifier le suivi systématique - familles	Stratégie pertinente de prise en charge	Clinicien
Transmettre les informations pertinentes au patient et ou à son entourage familles		

Attendu d'apprentissage spécifique "de la situation abordée"	Domaines	Compétence générique
Recueillir les données anamnéstiques et sémiologiques des différents organes qui évoquent une pathologie allergique	Examen Clinique	Clinicien

Déterminer la sévérité de la pathologie allergique	Entretien/interrogatoire	Réfléxif
Mener une enquête allergologique	Entretien/interrogatoire	Clinicien
Identifier les diagnostics différentiels (mécanismes non-allergiques)	Stratégie diagnostique	Réfléxif

https://livret.uness.fr/lisa/Consultation_post_événement_allergique_SDD-299 1/2 10/12/2023 22:47 Consultation post événement allergique SDD-299 — LiSA

Expliquer au patient/proche les explorations allergologiques adaptées	Annonce	Communicateur
Expliquer par écrit et oralement, les mesures préventives aux différents intervenants	Communication interprofessionelle	Coopérateur
Intégrer les différents mécanismes d'allergie ou d'hypersensibilité pour évaluer le risque évolutif	Stratégie diagnostique	Réfléxif
Expliquer au patient la nécessité de l'éviction de l'allergène identifié ou suspecté	Education/prévention	Communicateur

Attendu d'apprentissage spécifique "Valorisation du stage"	**Domaines**	**Compétence générique**
Prescrire une désensibilisation	Stratégie pertinente de prise en charge	Clinicien
Expliquer un projet d'acceuil individualisé pour l'école	Communication interprofessionelle	Communicateur
Expliquer l'utilisation d'une trousse d'urgence dont l'adrénaline autoinjectable	Education/prévention	Communicateur
Evoquer les potentielles allergies croisées	Education/prévention	Communicateur

Récupérée de « https://livret.uness.fr/lisa/index.php?title=Consultation_post_événement_allergique_SDD-299&oldid=68254 »

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-338-02-A
Item parent	Œdème de Quincke et anaphylaxie
Rang	A
Intitulé	Connaître les modalités du diagnostic d'un angioœdème histaminique (urticaire)
Description	Diagnostic de l'urticaire profonde.
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	
Ordre	2

- L'angio-oedème est un œdème localisé des tissus sous-cutanés ou sous-muqueux : tuméfaction sous-cutanée ou sous-muqueuse, localisée, ferme, douloureuse, non érythémateuse et non prurigineuse. Au niveau céphalique, il prédomine sur les paupières, les lèvres, la luette et la langue.
- L'angio-oedème histaminique est
  - est souvent associé à une urticaire
  - est sensible aux médicaments anti-histaminiques et glucocorticoïdes
  - se résout habituellement en 24 à 48 heures

Identifier les facteurs de gravité (anaphylaxie) lors d'un angioœdème OIC-338-05-A

Fiche LiSA

Validée

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-338-05-A
Item parent	Œdème de Quincke et anaphylaxie
Rang	A
Intitulé	Identifier les facteurs de gravité (anaphylaxie) lors d'un angioœdème
Description	Rechercher une atteinte laryngée, respiratoire, hémodynamique
Rubrique	Identification de l'urgence
Contributeurs	
Ordre	5

- critères de gravité des angio-œdèmes histaminiques : ce sont ceux qui définissent l'anaphylaxie
- critères de gravité des angio-œdèmes bradykiniques :
  - atteinte au-dessus des épaules (cou, visage, sphère ORL)
  - atteinte abdominale avec douleur cotée sur l'Échelle Visuelle Analogique au-dessus de 5/10

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-338-06-A
Item parent	Œdème de Quincke et anaphylaxie
Rang	A
Intitulé	Connaître les modalités d'administration du tout premier traitement en intramusculaire : adrénaline
Description	Savoir administrer de l'ADRENALINE en bolus de 0,01 mg/kg ou par seringue préparée
Rubrique	Prise en charge
Contributeurs	
Ordre	6

- **toute manifestation anaphylactique requiert l'injection intramusculaire immédiate d'adrénaline** :
  - la voie IM permet une administration plus rapide que la voie intraveineuse
  - adulte : 0.5 mg IM, à mi-hauteur sur la face latéro-externe de la cuisse.
  - Pour les sujets de moins de 50 kg, la dose est de 0.01 mg/kg.
- Si au moins un signe clinique mettant en jeu le pronostic vital (hypotension artérielle, dyspnée) persiste après 5 minutes : nouvelle injection IM de 0.5 mg (ou 0.01 mg/kg pour les sujets de moins de 50 kg)

Connaître le traitement symptomatique OIC-338-08-A

Fiche LiSA

Validée

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-338-08-A
Item parent	Œdème de Quincke et anaphylaxie
Rang	A
Intitulé	Connaître le traitement symptomatique
Description	Savoir administrer l'oxygène et débuter le remplissage (item 359 et item 332)
Rubrique	Prise en charge
Contributeurs	
Ordre	8

- antihistaminique anti-H1, actif sur les symptômes cutanéo-muqueux de l'anaphylaxie